

Quelle conduite à tenir en cas d'oubli d'une prise de traitement psychotrope ?

 Oublier une prise d'un traitement psychotrope peut arriver à tout le monde. Que faire quand on s'en aperçoit ? Quand on cherche des informations, on réalise rapidement qu'il y a peu d'instructions claires sur la conduite à tenir.

 Cette situation n'est pas spécifique aux psychotropes. Une étude portant sur plus de 2000 notices d'information médicamenteuses a montré que plus de moitié ne contenaient aucune instruction sur les prises manquées, et 1/3 juste des instructions très vagues (« prenez le aussi vite que possible »).

 L'oubli d'une seule prise de psychotropes a rarement des conséquences graves. Deux risques opposés sont à prendre en compte :

- ☞ perte d'efficacité ou symptômes de sevrage si la prise n'est pas rattrapée
- ☞ surdosage si la prise oubliée est rattrapée de manière trop proche de la prise suivante

 les informations générales suivantes ne s'appliquent pas à toutes les personnes, demandez l'avis d'un professionnel de santé pour votre situation particulière

 Une règle de base est de ne jamais rattraper la dose oubliée lors de la prise habituelle suivante. Par ex si on a oublié un soir des comprimés de lithium, il ne faut jamais prendre en plus les comprimés oubliés le soir suivant, car le risque de surdosage est très important.

 La vitesse d'élimination du médicament est un critère essentiel pour déterminer la conduite à tenir. La « $\frac{1}{2}$ vie » mesure cette vitesse : c'est le temps au bout duquel la concentration du médicament dans le sang est divisée par deux.

 La plupart des traitements psychotropes ont une $\frac{1}{2}$ vie suffisamment longue pour maintenir une concentration suffisante dans le sang jusqu'à la prochaine prise.

☞ pour limiter le risque de surdosage, une règle simple est de ne pas rattraper la prise manquée, et de poursuivre le traitement à la dose habituelle lors de la prise suivante

 Si la $\frac{1}{2}$ vie est courte (< 10h), le médicament est rapidement éliminé. Les benzodiazépines à $\frac{1}{2}$ vie courte sont les psychotropes les plus concernés (alprazolam, oxazépam, lorazépam, clotiazépam)

☞ une prise oubliée peut entraîner un rebond d'anxiété, des troubles du sommeil, etc .

☞ il vaut donc mieux « rattraper » la prise manquée, en prenant la dose entière si le retard est < 2h

☞ si le retard est > 2h, on peut prendre $\frac{1}{2}$ dose en attendant la prochaine prise

 En cas de prise oubliée, une diminution des effets peut aussi être ressentie pour les psychotropes les plus sédatifs :

☞ par ex oublier la quétiapine ou la clozapine le soir va souvent avoir des conséquences sur le sommeil

☞ La dose peut être rattrapée si le retard est < 2h, attention à ne pas la reprendre trop tard dans la nuit, car le réveil risque d'être compliqué, les effets sédatifs se décalent le matin.

🕒 Si l'oubli d'une prise est le plus souvent sans conséquence, la répétition des oublis a un impact sur l'efficacité du traitement. Des stratégies comme l'utilisation d'un pilulier, des alertes, ou une supervision de l'administration sont alors à envisager.

Références

https://reseau-pic.info/?page=../medicaments/fiches_2022/Anxiolytiques.php
<https://doi.org/10.1007/s00228-020-03003-x>

